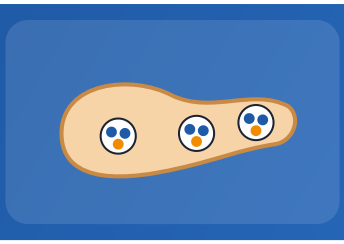
מצבי חירום אנדוקריניים

המערכת וההורמונים · בלוטת התריס · בלוטת האדרנל · האוגדן

דף סיכום · פודקאסטים קלוד



המערכת וההורמונים

מה המערכת עושה?

בקרה וויסות באמצעות **הורמונים**, במקביל למערכת העצבים: שמירה על הומאוסטזיס. ההורמון עובר בדם לכל הגוף, אבל רק לאיבר המטרה יש **קולטן ספציפי**.

כמו: מפתח שמתאים רק למנעול אחד.

מי מנהל?

ההיפותלמוס שולט בהיפופיזה, וגם מווסת את חום הגוף ואת חילוף החומרים. **היפופיזה קדמית:** TSH ← תריס, ACTH ← אדרנל (וגם GH, FSH, LH, פרולקטין, MSH). **אחורית:** ADH (נוגד השתנה), אוקסיטוצין.

הבלוטות וההורמונים

תריס ויותרת התריס: T4, T3, PTH, קלציטונין · לבלב: אינסולין, גלוקגון, סומטוסטטין · אדרנל: קורטיזול, אלדוסטרון · אצטרובל: מלטונין · תימוס: תימוסין, תימופויטין · שחלות ואשכים: אסטרוגן, פרוגסטרון, טסטוסטרון.

בלוטת התריס

איך זה עובד?

התריס צריכה **יוד וטירוזין**. TSH מעודד אותה לייצר **T4** ו**-T3**, ו-T4 הופך ברקמות ל-**T3 הפעיל**. התפקיד: קצב המטבוליזם וחום הגוף.

כמו: דוושת הגז של הגוף: יותר מדי הורמון והכל מואץ, מעט מדי והכל מאט.

תת פעילות: הכל בירידה

הדרגתי. עייפות, רגישות לקור, השמנה, עצירות, ברדיקרדיה, גויטר. השימוטו, פרוקור, ליתיום, חסר יוד.

יתר פעילות: הכל בעלייה

גרייבס (85%). ערנות, רעד, הזעה, שלשולים, ירידה במשקל, בליטת עיניים, טכיקרדיה.

שימו לב: תרדמת מיקסדמה: לא נטל אלתרוקסין או מחלת חום. ירידה בהכרה, **היפותרמיה בלי רעד**, היפוגליקמיה, ברדיפניאה, ברדיקרדיה, שוק.

שימו לב: סערה תירואידית: חום קיצוני, אגיטציה, טכיקרדיה, היפרגליקמיה ואחריה היפוגליקמיה, פוליאוריה.

בשטח: מיקסדמה: ABC, נוזלים ומכווצי כלי דם לפי הצורך, **בודקים סוכר**. סערה: ABC, **קירור**; חוסמי בטא שוקלים **רק באישור מוקד רפואי**.

בלוטת האדרנל

מה היא מייצרת?

קליפה: קורטיזול (הורמון הדחק), אלדוסטרון (שומר נפח ומעלה ל"ד). **לשד:** אדרנלין, נוראדרנלין, דופמין. בעיה מרכזית (היפופיזה) או פריפרית (אדרנל).

משבר אדרנלי: למה שוק?

חסר חד באלדוסטרון ו/או קורטיזול ← **היענות נמוכה לאנגיוטנסין ולנוראפינפרין**. בלי קורטיזול כלי הדם מגיבים פחות לנוראדרנלין; בלי אלדוסטרון נפח הדם יורד ← לחץ הדם קורס.

שימו לב: שוק, חום, שינויים בהכרה, היפוגליקמיה, ברדיקרדיה עד דום לב. **גם בלי אדיסון: הפסקה חדה של סטרואידים.**

אדיסון: מטופל ירוד

תשישות, כאבי בטן, ירידה במשקל, שינויי צבע עור, היפוגליקמיה, היפוטנשן, היפותרמיה; תיתכן היפרקלמיה ← אק"ג.

קושינג: עודף

פני ירח, דבשת באפלו, סימני מתיחה, היפרגליקמיה. לא מסכן חיים, אבל סטרואידים ממושכים ← סכנת משבר בהפסקה.

מד"א: ירידה בפרפוזיה, ענף "אחר"

1. בתשאול: טיפול קבוע בסטרואידים? אדיסון?
2. שקול חמצן · תן עירוי נוזלים
3. שקול סולומדרול 125 mg IV (מבוגר)
4. שקול אדרנלין 10–20 mcg IV בפוש (2 דק' בין מנות) · שקול דופמין 5–20 mcg/kg/min
5. פינוי דחוף, ניטור, דיווח מקדים

3 דברים לזכור

1. **תת פעילות: הכל בירידה · יתר פעילות: הכל בעלייה**
2. **שוק לא מוסבר? שואלים על סטרואידים · שקול סולומדרול 125 mg IV**
3. **כל שינוי בהכרה: בודקים סוכר**

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס, קפ"ע Mosby, 15 והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון.